CENTRO DE PESQUISA INTERPROFISSIONAL EM ULTRASSONOGRAFIA POINT-OF-CARE
CePI-POCUS

ULTRALAB
Laboratório POCUS em Enfermagem
UFPR

Caso Clínico: Constipação

1. Identificação do caso

Título do caso: Constipação intestinal em paciente idoso hospitalizado com insuficiência cardíaca

Tema principal: Constipação intestinal / fecaloma

Área clínica: Clínica médica

Nível de necessidade humana básica afetada, segundo Horta (1979):

1. Avaliação das Necessidades Psicobiológicas
- Hidratação
- Nutrição (alimentação)
- Eliminação intestinal e urinária
- Mecânica corporal, motilidade

Autor(a):

Data:

2. Objetivo do caso

- Objetivo clínico: Identificar sinais e sintomas de constipação intestinal e fecaloma em paciente hospitalizado.
- Objetivo cognitivo: Desenvolver raciocínio clínico para correlacionar dados clínicos e achados ultrassonográficos.
- Objetivo técnico: Utilizar o PoCUS para avaliação transabdominal do reto.

3. Apresentação inicial do paciente - versão técnica

- Identificação: Sr. José A. M., 78 anos, sexo masculino
- Motivo da internação/atendimento: Descompensação de insuficiência cardíaca.
- Queixa principal atual: Dor abdominal e ausência de evacuação há 4 dias.
- História clínica resumida: Paciente com IC descompensada evolui após melhora parcial com dor abdominal, distensão, redução do apetite e constipação, associado à imobilidade, baixa ingesta e uso de diuréticos
    - admitido na unidade de clínica médica por descompensação de insuficiência cardíaca, com queixa de dispneia aos pequenos esforços, ortopneia, edema em membros inferiores e fadiga progressiva há uma semana. Apresenta antecedentes de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, hipertensão arterial sistêmica, fibrilação atrial, doença renal crônica estágio 3 e diabetes mellitus tipo 2. Após melhora parcial do quadro congestivo no terceiro dia de internação, o paciente passou a referir dor abdominal difusa, de intensidade moderada, associada a sensação de distensão abdominal, desconforto à palpação e redução do apetite. Relatou ausência de evacuação há 4 dias,

4. Antecedentes pessoais e clínicos

Comorbidades: Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, HAS, Fibrilação atrial, DRC estágio 3, DM tipo 2.

Histórico médico-cirúrgico relevante: Não relatado

Medicamentos em uso:

- Domiciliar:
- Furosemida
- Espironolactona
- Carvedilol
- Enalapril
- Digoxina
- Apixabana
- Metformina

- Durante a internação:
- Diurético intravenoso

Alergias: Não relatada

Outras informações relevantes: Restrição hídrica e controle de balanço hídrico

5. Avaliação clínica atual - (Sinais vitais)

A – Via aérea (Airway)

- Permeabilidade da via aérea:
  - (X) Pérvia
  - ( ) Parcialmente obstruída
  - ( ) Obstruída
- Presença de:
  - ( ) Secreções
  - ( ) Corpo estranho
- Necessidade de intervenção:
  - (X) Não
  - ( ) Sim → Qual? _____

B – Respiração (Breathing)

- Frequência respiratória (irpm): 24irpm
- Saturação de O_2 (%): 93% AA
- Uso de musculatura acessória
  - (X) Sim
  - () Não

- Padrão respiratório:
    - ( ) Eupneico
    - ( ) Taquipneico
    - ( ) Bradipneico
    - (X) Dispneico
    - ( ) Irregular
- Ausculta pulmonar:
    - ( ) Murmúrio vesicular presente
    - ( ) Reduzido
    - (X) Estertores (bibasais finos)
    - ( ) Sibilos
- Expansibilidade torácica:
    - (X) Simétrica
    - ( ) Assimétrica
- Oxigenoterapia: **NÃO**
    - Tipo: _____
    - Fluxo: _____

C – Circulação (Circulation)

- Frequência cardíaca (bpm): 96 bpm
- Pressão arterial (mmHg): 104/68 mmHg
- Perfusão periférica:
    - Tempo de enchimento capilar: _____ s
    - Extremidades:
        - ( ) Quentes
        - (X) Frias
- **Pulsos:**
    - (X) Palpáveis
    - ( ) Filiformes
    - ( ) Ausentes
- **Ritmo cardíaco:**
    - (X) Regular
    - ( ) Irregular
- **Débito urinário (se disponível):**
- **Presença de edema:**
    - (X) Sim (edema ++/4+ em membros inferiores)
    - ( ) Não
- **Temperatura corporal:** 36,5ºC

D – Avaliação neurológica (Disability)

- **Nível de consciência:**
    - (X) Alerta

    - (X) Orientado
    - ( ) Responde à voz
    - ( ) Responde à dor
    - ( ) Inconsciente

OU (opcional):

- **Escala de Glasgow: _____**
- **Pupilas:**
    - ( ) Isocóricas
    - ( ) Anisocóricas
    - ( ) Fotorreagentes
    - ( ) Não reagentes
- **Glicemia capilar:**
- **Déficits neurológicos focais:**
    - ( ) Sim
    - (X) Não

E – Exposição (Exposure)

- **Avaliação da pele:**
    - ( ) Íntegra
    - ( ) Lesões
    - ( ) Cianose
    - ( ) Palidez
    - ( ) Sudorese
    - (X) Hipocorado (+/4+)
- **Presença de:**
    - (X) Edema
    - ( ) Hemorragias
    - ( ) Lesões por pressão
- **Dor:**
    - Escala (0–10): 5 (moderada)
- **Outros achados relevantes:**

AVALIAÇÃO FÍSICA COMPLEMENTAR:

Avaliação abdominal: Globoso, distendido, timpânico à percussão, RHA diminuídos e dor leve à palpação difusa, sem sinais evidentes de irritação peritoneal.

6. Dispositivos e suportes em uso

(X) Acesso venoso periférico

( ) Cateter venoso central

( ) Cateter vesical de demora

( ) Sonda enteral

( ) Oxigenoterapia

( ) Ventilação mecânica

( ) Dreno

(X) Monitorização contínua

( ) Outro: _____

7. Dados complementares disponíveis

Mantinha diurese presente, porém concentrada. O balanço hídrico dos últimos dias mostrava importante restrição de líquidos associada ao uso de diuréticos. Familiar relatou que o paciente vinha apresentando esforço evacuatório frequente em casa e necessidade eventual de laxativos.

8. Situação-problema do caso

Paciente evolui no terceiro dia de internação com dor abdominal difusa, de intensidade moderada, associada a sensação de distensão abdominal, desconforto à palpação, baixa ingesta alimentar e hídrica, e ausência de evacuação há 4 dias, associado à redução da mobilidade ficando restrito ao leito.

9. Hipótese clínica principal

Constipação intestinal com retenção fecal distal (fecaloma)

10. Aplicação do POCUS no caso - Qual é o objetivo do POCUS neste caso?

(X) Confirmar hipótese clínica

( ) Guiar procedimento

(X) Complementar avaliação clínica

( ) Monitorar evolução

(X) Guiar conduta

Tipo de avaliação ultrassonográfica esperada: Ultrassonografia transabdominal do reto não invasiva

Estrutura(s) a ser(em) avaliada(s): Ampola retal

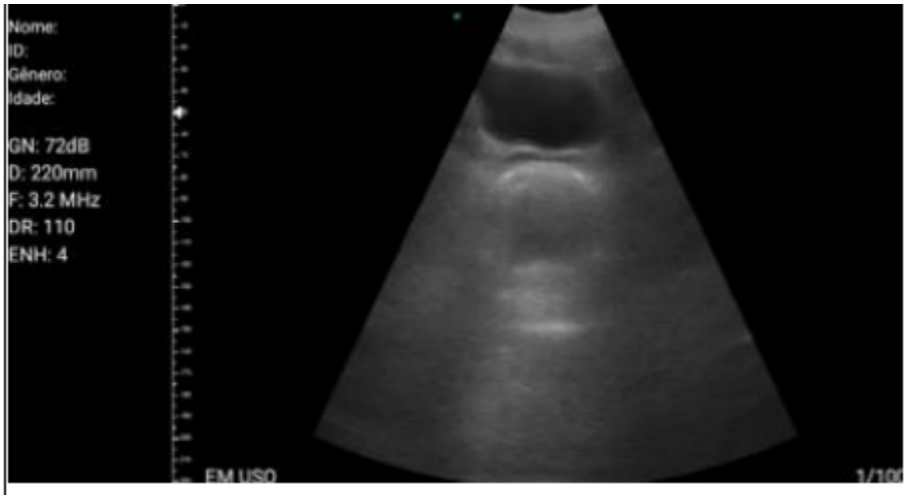
Pergunta clínica que o POCUS deve responder: Há presença de fecaloma?

12. Achados esperados no POCUS

Achado principal: Imagem hiperecogênica com sombra acústica posterior no reto

Configurações do POCUS: Transdutor convexo, região suprapúbica, uso da bexiga como janela acústica

Pergunta: Ao realizar a ultrassonografia transabdominal do reto, observa-se uma imagem hiperecogênica com sombra acústica posterior localizada na região retal. Qual é a interpretação mais adequada desse achado?



A) Presença de líquido livre na pelve

B) Conteúdo fecal endurecido compatível com fecaloma/impactação fecal

C) Alça intestinal preenchida por gás sem relevância clínica

D) Espessamento da parede vesical

Resposta correta: B) Conteúdo fecal endurecido compatível com fecaloma/impactação fecal

Feedback: A presença de imagem hiperecogênica com sombra acústica posterior na topografia do reto sugere fortemente material fecal endurecido, achado compatível com impactação fecal/fecaloma, especialmente quando associado a dor abdominal, distensão e ausência de evacuação.

Pergunta: Durante a avaliação ultrassonográfica transabdominal do reto, qual achado sugere maior probabilidade de conteúdo fecal impactado na ampola retal?

A) Estrutura anecoica homogênea posterior à bexiga

B) Imagem hiperecogênica intrarretal associada a sombra acústica posterior

Pergunta: Qual transdutor é mais indicado para iniciar a ultrassonografia transabdominal do reto nesse paciente?

A) Linear de alta frequência

B) Convexo de baixa frequência

C) Setorial cardíaco

D) Endocavitário

Resposta correta: B) Convexo de baixa frequência Feedback se acertar: Correto. O transdutor convexo de baixa frequência permite maior penetração e melhor avaliação das estruturas pélvicas profundas, sendo geralmente o mais indicado para avaliação transabdominal do reto em adultos.

Feedback se errar: Incorreto. Para a avaliação transabdominal do reto, costuma-se preferir um transdutor com maior penetração, capaz de visualizar melhor as estruturas profundas da pelve.

13. Interpretação clínica esperada

Achados ultrassonográficos associados ao quadro clínico confirmam retenção fecal distal.

Pergunta: Considerando o quadro clínico do paciente idoso hospitalizado por insuficiência cardíaca, com dor abdominal, distensão e ausência de evacuação há 4 dias, qual seria a conduta mais esperada?

A) Realizar ultrassonografia transabdominal do reto como avaliação não invasiva

B) Instituir medida de esvaziamento distal, como Fleet enema ou supositório retal, conforme avaliação clínica e prescrição institucional

C) Manter apenas observação clínica por mais 48 horas

D) Suspender toda investigação abdominal, pois a constipação não se relaciona ao quadro clínico

Pergunta: Considerando o caso clínico e um exame ultrassonográfico mostrando conteúdo hiperecogênico com sombra acústica no reto, qual é a interpretação mais adequada?

A) Bexiga vazia sem relevância clínica

B) Ascite pélvica associada à insuficiência cardíaca

C) Distensão retal por acúmulo fecal, compatível com fecaloma/constipação distal

D) Massa sólida pélvica de origem indefinida

Pergunta: Ao identificar distensão retal com conteúdo hiperecogênico e sombra acústica posterior nesse paciente, qual a interpretação mais adequada?

A) Bexiga vazia sem alteração intestinal

B) Ascite pélvica

C) Retenção fecal distal/fecaloma

D) Massa vesical

Resposta correta: C) Retenção fecal distal/fecaloma

Feedback se acertar: Correto. No contexto clínico de dor abdominal, distensão e 4 dias sem evacuação, esse achado é compatível com retenção fecal distal, podendo representar fecaloma.

Feedback se errar: Incorreto. A associação entre quadro clínico e imagem ultrassonográfica sugere fortemente retenção fecal no reto.

Pergunta: Durante o exame, qual achado ultrassonográfico é mais sugestivo de conteúdo fecal impactado no reto?

A) Estrutura anecoica homogênea

B) Imagem hiperecogênica com sombra acústica posterior

C) Líquido livre em pelve

D) Imagem hipoecoica com reforço posterior

Resposta correta: B) Imagem hiperecogênica com sombra acústica posterior Feedback se acertar: Correto. Fezes endurecidas ou fecaloma podem aparecer como imagem hiperecogênica associada a sombra acústica posterior, achado compatível com impactação fecal.

Feedback se errar: Incorreto. O conteúdo fecal endurecido costuma gerar importante reflexão do feixe ultrassonográfico, produzindo imagem ecogênica e sombra posterior.

Pergunta: Qual é o local mais adequado para posicionar o transdutor na obtenção da imagem do reto por via transabdominal?

A) Hipocôndrio direito

B) Região suprapúbica/hipogástrica

C) Flanco esquerdo

D) Região epigástrica

Resposta correta: B) Região suprapúbica/hipogástrica

Feedback se acertar: Correto. O transdutor deve ser posicionado na região suprapúbica, utilizando preferencialmente a bexiga como janela acústica para facilitar a visualização do reto posteriormente.

Feedback se errar: Incorreto. A avaliação transabdominal do reto é feita na pelve, e a região suprapúbica é a mais utilizada para aquisição da imagem.

Pergunta: Em um idoso hospitalizado com dor abdominal e ausência de evacuação há 4 dias, qual transdutor é o mais indicado para iniciar a ultrassonografia transabdominal do reto?

A) Transdutor linear de alta frequência

B) Transdutor convexo de baixa frequência

C) Transdutor setorial cardíaco

D) Transdutor endocavitário

Pergunta: Para obtenção da imagem ultrassonográfica transabdominal do reto, qual é o local mais adequado para posicionar o transdutor?

A) Hipocôndrio direito, abaixo do rebordo costal

B) Região periumbilical

C) Região suprapúbica/hipogástrica, utilizando a bexiga como janela acústica

D) Fossa ilíaca esquerda, diretamente sobre o sigmoide

14. Conduta esperada

Considerando o quadro clínico e os achados sugestivos de retenção fecal distal, qual conduta é mais esperada?

A) Ultrassonografia transabdominal do reto como tratamento

B) Fleet enema ou outra medida de esvaziamento distal

C) Apenas observação por 48 horas

D) Aumentar restrição hídrica

Resposta correta: B) Fleet enema ou outra medida de esvaziamento distal

Feedback se acertar: Correto. A ultrassonografia auxilia na avaliação diagnóstica, mas a intervenção mais esperada diante de constipação distal/fecaloma é uma medida de desimpactação, como enema ou supositório, conforme avaliação clínica e prescrição institucional.

Feedback se errar: Incorreto. Nesse contexto, a ultrassonografia é uma ferramenta de avaliação, enquanto a conduta terapêutica mais esperada é o esvaziamento retal.

15. Evolução esperada do paciente

Melhora da dor abdominal, evacuação e redução da distensão.

16. Possíveis erros ou condutas inadequadas

17. Diagnósticos de Enfermagem

Corretos:

- Constipação
- Mobilidade física prejudicada
- Risco de desequilíbrio hidroeletrolítico

Incorretos:

- Troca gasosa prejudicada
- Integridade da pele prejudicada
- Ansiedade grave

18. Intervenções de enfermagem (NIC)

Corretas:

- Monitorar eliminação intestinal
- Incentivar mobilidade
- Administrar enema conforme prescrição

Incorretas:

- Restringir ainda mais líquidos
- Manter repouso absoluto
- Ignorar queixa abdominal

19. Feedback educacional/Mensagem final de aprendizagem

Acerto:
Parabéns! Você identificou corretamente a retenção fecal e realizou a conduta adequada, prevenindo complicações.

Erro:
A ausência de intervenção pode levar a fecaloma, dor intensa e complicações intestinais.

20. Versão narrativa - Você está no plantão da clínica médica quando um paciente idoso internado por insuficiência cardíaca começa a apresentar dor abdominal e distensão. Ele não evacua há dias. Sua decisão pode mudar completamente a evolução do caso!

21. Referências que embasam o caso